

 OSPEDALE PEDIATRICO SANTOBONO PAUSILIPON "curiamo i bambini, curiamo il futuro"	Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono-Pausilipon" Dipartimento di Neuroscienze U.O.C. di NEURORADIOLOGIA - Direttore: dr. Eugenio M. COVELLI Via Mario Fiore,6 - 80129 - Napoli Tel : 081/220.5682- 220.5684
---	--

Dirigenti Medici: dr. Daniele CASCONI dr. Domenico CICALA dr. Simone COLUCCINO dr.ssa A. CRISTOFANO dr.ssa Maria DE LISO dr.ssa Federica MAZIO dr.ssa Anna NASTRO dr.ssa Camilla RUSSO dr.ssa Carmela RUSSO dr.ssa Chiara PAOLELLA Coordinatore TSRM: dott. P. PISA TSRM dott.ssa R.T. NACLERIO dott.ssa A.L. OREFICE dott.ssa A. PEZZULLO dott.ssa V. REA dott.ssa S. SICILIANO dott.ssa M. UMMARO dott. P. VOLATILE dr.ssa Anastasia MARANO	PAZIENTE VIOLA LORENZO		PROVENIENZA SANTOBONO - Neurochirurgia pediatrica	
	Data di Nascita 26/11/2025		Codice Paziente SNB234864	
	TSRM dott.ssa Esposito Mariagrazia		Data Esame 19/05/2026	
	ESAME: (D.Lgs 101/2020 commi 5-6)			Classe di Dose:
	RM encefalo (senza contrasto)			-
	Quesito diagnostico: protocollo craniostenosi			

Testo del Referto:

Quesito clinico (come da richiesta): protocollo craniostenosi.

Esame eseguito su scanner 3T, senza somministrazione endovenosa di mezzo di contrasto paramagnetico, secondo protocollo di studio dedicato CRS e integrato da esame TC "low dose".

In relazione al quesito clinico, si rileva trigonocefalia per sinostosi della sutura metopica con cresta ossea mediana corrispondente. Si determina riduzione volumetrica e secondario dismorfismo della fossa cranica anteriore, a cui si adattano i lobi frontali ed i corrispettivi spazi subaracnoidei. Non chiaramente visibile il bulbo ed il solco olfattorio di destra.

Non si rilevano aree di alterato segnale a carico del tessuto nervoso encefalico; conservata la rappresentazione della mielinizzazione, congrua con l'età anagrafica.

Normo-conformati il corpo calloso, il tronco encefalico e il cervelletto.

Nella norma la morfo-metria del restante sistema ventricolo-cisternale sotto e sopratentoriale. Verniciatura emosiderinica lungo il terzo posteriore della falce tentoriale, il margine libero del tentorio a destra ed in sede retrocerebellare.

Asimmetria del segnale di flusso degli assi venosi trasverso-sigmoido-giugulari per dominanza del destro; nella norma decorso e segnale di flusso dei restanti collettori venosi durali.

Non si osservano significative alterazioni focali e/o asimmetrie emisferiche della perfusione cerebrale.

Aspetto lievemente appiattito della bozza occipitale destra.